

monotropism-autism-prevalence-global_es

Autismo y monotropismo: ¿son realmente tan comunes?

Un brief de investigación citado — verificando las cifras regionales de autismo y la pregunta «qué porcentaje de personas son monotrópicas».

Informativo, no consejo médico. Estas cifras describen cuántas personas se cuentan como autistas o puntúan alto en una escala de monotropismo. Contar depende en gran medida de quién busca, cómo y dónde. Nada aquí es diagnóstico.

Resumen ejecutivo

- **El autismo no es 1 % en todas partes.** La cifra global más fiable es la estimación del **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, ya adoptada por la OMS: alrededor de **1 de cada 127 personas (~0,8 %)** estaba en el espectro autista en 2021 [1][2]. Para los *niños*, las revisiones agrupadas siguen situándose cerca del **~1 de cada 100** de toda la vida [3]. Los Estados Unidos — el país con el cribado más intensivo — reporta **1 de cada 31 (3,2 %)** entre los niños de 8 años (CDC, datos 2022) [4].
- **Las diferencias regionales son sobre todo un artefacto de medición, no biología.** El mismo estudio GBD encontró la carga relacionada con el autismo *más baja* en Asia Sudoriental/Oriental y Oceanía y *más alta* en la suprarregión de ingresos altos [1]. Ese patrón sigue la infraestructura diagnóstica, la concienciación y el cribado — no diferencias reales en la frecuencia del autismo.

- **La tabla regional frecuentemente citada es sustancialmente errónea para Oriente Medio y simplificada en exceso para Asia.** Una metanálisis de 2025 sitúa la prevalencia agrupada de Oriente Medio y Norte de África (MENA) en solo ~0,14 % (rango 0,01 % Omán → 2,51 % Arabia Saudí) [6], y una metanálisis asiática reporta para Asia Oriental ~0,51 % y China continental ~0,7 % [5][7] — muy por debajo del «0,9–1,5 %» que a menudo se afirma para el mundo árabe.
- **El monotropismo no tiene una «prevalencia» acordada, y la cifra «15–20 % de las personas son monotrópicas» es un error de categoría.** El monotropismo es un estilo cognitivo *dimensional* (un rasgo continuo), no un diagnóstico. El único estudio empírico grande — el **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — encontró que los participantes autistas promediaron 4,15/5 y los no autistas 3,19/5, con un solapamiento sustancial [10]. No dice «X % de las personas son monotrópicas».
- **La afirmación «>90 % de las personas autistas son monotrópicas» es una afirmación teórica sobre cómo de bien capta la teoría la experiencia autista, no un porcentaje medido.** Es defendible como *validez subjetiva*, engañosa como *epidemiología*.

1. ¿Cuántas personas son autistas? (y por qué existen dos cifras estelares)

Dos cifras circulan, y responden a preguntas ligeramente distintas:

- **~1 de cada 100 niños.** Esta es la cifra agrupada a través de docenas de estudios en revisiones sistemáticas (p. ej. Zeidan et al., 2022) y es el resumen de la OMS de larga data *centrado en los niños* [3]. Refleja estudios que criban sobre todo poblaciones pediátricas.
- **1 de cada 127 personas (~0,79 %), todas las edades.** Esta es la estimación modelada del **GBD 2021** — 61,8 millones de personas en 2021 — que la OMS ha adoptado ahora literalmente («En 2021 aproximadamente 1 de cada 127 personas tenía autismo») [1][2]. Es más baja per cápita porque abarca toda la vida, incluidas las generaciones mayores que nunca fueron cribadas.

La brecha entre «1 de cada 100» y «1 de cada 127» no es una contradicción: la primera son niños, la segunda todo el mundo. Ambas son defendibles si se especifica la población.

El GBD también da un desglose por sexo claro — aproximadamente **1,06 % de los hombres** frente a **0,51 % de las mujeres** (1.064,7 vs 508,1 por 100.000) — reflejando la infridentificación bien documentada de niñas y mujeres autistas, no una diferencia biológica del doble [1].

2. Por qué difieren los números regionales (las diferencias miden sobre todo *detección*, no biología)

Este es el punto más importante para leer cualquier tabla regional. Los autores del GBD 2021 encontraron que la carga sanitaria relacionada con el autismo iba desde **126,5 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) por 100.000** en la suprarregión Asia Sudoriental / Asia Oriental / Oceanía hasta **204,1 por 100.000** en la suprarregión de ingresos altos [1]. En términos llanos: las partes del mundo más ricas y con más cribado *encuentran* mucho más autismo que el resto.

Los impulsores de la brecha son casi enteramente metodológicos y sociales:

- **Infraestructura diagnóstica** — las redes de vigilancia activa (p. ej. el ADDM de los CDC de EE. UU.) buscan casos sistemáticamente en escuelas y clínicas; muchos países no tienen tal sistema y dependen de registros clínicos pasivos.
- **Criterios y concienciación** — el cambio del estrecho «trastorno autista» (DSM-IV) al espectro autista más amplio (DSM-5, 2013), más una concienciación pública y profesional creciente, ha aumentado constantemente la prevalencia *identificada* en los países que vuelven a cribar.
- **Estigma, idioma y acceso a servicios** — en muchas regiones el autismo se infrareporta porque las familias afrontan estigma, faltan servicios o las herramientas de cribado no están validadas en el idioma y la cultura locales.

Así que cuando una tabla muestra «0,1 % en la región X y 3 % en la región Y», léalas como «*la región Y busca más intensamente y tiene más capacidad de diagnosticar*», no «*el autismo es treinta veces más raro en la*

región X». Los autores del GBD destacan exactamente esto: se necesita una mejor cobertura de datos global antes de que la variación geográfica pueda interpretarse con confianza [1].

3. Una tabla regional corregida

Las cifras que motivaron este brief se reproducen frente a la mejor evidencia disponible. Las columnas «Mejor estimación» citan revisiones sistemáticas primarias o el modelo GBD — no redondeos de incidencia.

Región	Cifra a menudo citada	Lo que la evidencia apoya	Fuente
Mundo — todas las edades	«1 %»	1 de cada 127 (~0,79 %) en 2021 (GBD; ahora la cifra de la OMS)	[1][2]
Mundo — niños	«1 de cada 100»	~1 niño de cada 100 (revisiones agrupadas)	[3]
Norteamérica	«1–3,2 %»	3,2 % (1 de cada 31) niños estadounidenses de 8 años (2022, CDC ADDM); ~1 adulto de cada 45	[4]
Europa	«0,7–1 %»	Los estudios basados en registros se agrupan en torno a ~1 % (p. ej. Dinamarca, Finlandia, Islandia); las estimaciones poblacionales algo más altas	[3]
Oriente Medio y Norte de África	«0,9–1,5 %»	Agrupado ~ 0,14 % (IC 95 % 0,02–0,36 %); rango por país 0,01 % (Omán) → 2,51 % (Arabia Saudí)	[6]
Asia Oriental / Sudoriental	«0,4–1,4 %»	Metanálisis asiática: Asia Oriental ~ 0,51 % , Asia del Sur ~0,31 %, Asia Occidental ~0,35 %; China continental ~ 0,7 % (1 de cada 143) ; bolsas con cribado intensivo (Singapur, Japón, Corea del S.) reportan más	[5][7]

Dos conclusiones de la tabla:

1. Los rangos **norteamericano** y **européo** son ampliamente correctos — son las regiones con más cribado, por lo que sus números altos son esperables.

2. La cifra **MENA** es el gran error. Una prevalencia agrupada cercana al **0,14 %** refleja casi con certeza *infradiagnóstico y vigilancia débil*, no un autismo genuinamente más raro. La enorme dispersión intra-región (Omán 0,01 % a Arabia Saudí 2,51 %) es en sí misma la señal: la biología real no varía tanto entre países vecinos; la vigilancia sí [6].

4. ¿Está realmente «aumentando» el autismo?

La prevalencia estelar ha subido fuertemente — en EE. UU. de aproximadamente 1 de cada 150 (2000) a 1 de cada 31 (2022) [4]. La explicación dominante entre los epidemiólogos es una **mejor y más amplia identificación**, no necesariamente más autismo:

- criterios ampliados (DSM-IV → DSM-5),
- búsqueda activa de casos (vigilancia tipo ADDM),
- cribado más temprano y equitativo por sexo, raza y etnia,
- estigma reducido que lleva a más evaluaciones.

Los autores del GBD señalan que la prevalencia ha sido comparativamente *estable* donde se controla la calidad de los datos, y que los «aumentos» aparentes siguen sobre todo la capacidad de detección [1]. El resumen honesto: **estamos contando cada vez más un autismo que siempre ha estado ahí**.

5. ¿Cuántas personas son «monotrópicas»? (la pregunta que no tiene una única respuesta)

El monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) es un relato del autismo *basado en la atención*: una mente monotrópica concentra sus recursos en pocos «túneles de atención» intensamente activados, en lugar de repartir la atención entre muchos canales (poliotropismo). Crucialmente, se enmarca como una **diferencia en la asignación de la atención, no un déficit** — y como un **espectro**, no una categoría sí/no.

Por ello, **no hay una prevalencia acordada de «monotropismo»**, por tres razones estructurales:

1. **No es un diagnóstico.** El monotropismo no aparece en el DSM-5 ni en la CIE-11. No hay registro de casos ni umbral diagnóstico.
2. **Es dimensional, no categórico.** Todo el mundo puede entrar en un estado de «flujo» concentrado; la diferencia autista es que el enfoque

profundo y estrecho es el *modo operativo por defecto* más que un estado ocasional. Una línea entre «monotrópico» y «poliotrópico» sería arbitraria.

3. **El instrumento reporta medias, no casos.** El instrumento validado — el **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — arroja una puntuación continua de 1 a 5, y los investigadores comparan *medias de grupo*, no «cuántas personas superan un punto de corte» [10].

Los números reales que tenemos (estudio de validación del MQ)

En el estudio de desarrollo del MQ (1.110 participantes: 756 autistas, 354 no autistas) [10]:

- **Participantes autistas: media 4,15 / 5** (DE 0,347)
- **Participantes no autistas: media 3,19 / 5** (DE 0,578)
- **El estatus TDAH** predijo independientemente puntuaciones más altas de monotropismo (relevante porque autismo y TDAH co-ocurren en aproximadamente el 30–80 % de los casos según la dirección).
- Un análisis factorial exploratorio produjo una **estructura de 8 factores** (intereses especiales; rumiación/ansiedad; necesidad de rutinas; entorno y el túnel de atención; perder el rastro del entorno; toma de decisiones; efecto reductor de ansiedad de los intereses; gestionar las interacciones sociales).

El solapamiento entre las dos distribuciones es sustancial — muchas personas no autistas puntúan por encima de algunas puntuaciones de personas autistas, y viceversa. Ese solapamiento es *exactamente* por qué un titular «X % de la población es monotrópica» no es significativo sin un punto de corte arbitrario (y discutido).

6. De dónde vienen las cifras «>90 %» y «15–20 %» — y por qué no son datos de prevalencia

Estos dos números, muy difundidos en línea, merecen una verificación directa.

«>90 % de las personas autistas son monotrópicas». Esto se lee mejor como una afirmación sobre **validez subjetiva** — esto es, *cuando las personas autistas se encuentran con el encuadre del monotropismo, una mayoría abrumadora lo reconoce como una descripción precisa de su*

experiencia. Es un fenómeno real y significativo (el MQ se construyó *con* un grupo comunitario liderado por autistas precisamente porque la descripción resonaba [10]). Pero **no es una prevalencia epidemiológica**; ningún estudio ha calculado «la proporción de personas autistas que son monotrópicas» frente a un umbral validado, porque no hay umbral acordado. Enunciado como «*el monotropismo tiene una validez subjetiva muy alta para las personas autistas*», es defendible; enunciado como «*más del 90 % de las personas autistas son monotrópicas*», sobrestima lo que se ha medido.

«15–20 % de la población general es monotrópica». Esta cifra es casi con certeza una **confluencia con la «neurodivergencia»**. Las estimaciones comunitarias sitúan *alguna* forma de neurodivergencia (TDAH, dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, etc., con fuerte solapamiento) en el orden del 15–20 % de la población. Para contexto, incluso los componentes mejor medidos son mucho menores de forma aislada: el TDAH adulto afecta a aproximadamente **2,58 %** (persistente) a **6,76 %** (sintomático) de los adultos globalmente [8], y el TDAH infantil se estima comúnmente en torno al 5–8 %. La dislexia suele citarse cerca del ~10 % según la definición. **Ninguna de estas es una cifra de monotropismo**. Igualar «neurodivergente» con «monotrópico» es un error de categoría: el monotropismo es una *dimensión* de estilo cognitivo que está elevada en — pero no es idéntica a — varios perfiles neurodivergentes. Actualmente **no hay un número basado en evidencia** para la prevalencia del monotropismo en la población general.

Conclusión sobre el monotropismo: *trátelo como una tendencia medible en un espectro, fuertemente (pero no exclusivamente) asociada con el autismo y el TDAH, con una alta validez de experiencia vivida para las personas autistas. La respuesta honesta a «¿qué porcentaje de personas son monotrópicas?» es: todavía no es una pregunta bien definida, y cualquier porcentaje preciso que vea está inventado.*

7. Conclusiones prácticas

- **Cite la cifra que coincida con la población.** «1 de cada 127 personas» (todas las edades, GBD/OMS) y «~1 niño de cada 100» son

ambas correctas — diga cuál quiere decir [1][2][3].

- **Trate las brechas regionales como brechas de detección.** La baja prevalencia reportada en MENA, partes de Asia, y entre niñas/mujeres, adultos mayores y grupos racializados refleja infridentificación, no ausencia [1][6].
- **No presente el monotropismo como teniendo una prevalencia.** Reporte medias del MQ y el encuadre dimensional; evite «>90 %» y «15–20 %» como afirmaciones de prevalencia [10].
- **Mantenga el encuadre neuroafirmativo.** Una mayor *identificación* del autismo en países bien dotados es un éxito de concienciación y acceso; monotrópico frente a politrópico es una *diferencia de atención*, no un déficit — coherente con cómo los creadores y la comunidad autista enmarcan la teoría.

Fuentes

[1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19 dic. 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8 M de personas (1 de cada 127) en 2021; prevalencia estandarizada por edad 788,3/100.000 (hombres 1.064,7; mujeres 508,1); DALYs suprarregionales 126,5 (Asia SE/E y Oceanía) a 204,1 (ingresos altos) por 100.000. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext) · resumen IHME:

<https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>

[2] Organización Mundial de la Salud (2024). *Autism fact sheet (key facts)*. — «In 2021 about 1 in 127 persons had autism.» <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

[3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 niño de cada 100; datos de registros europeos (Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>

- [4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 de cada 31 (3,2 %) entre los niños de 8 años. Informe comunitario:
<https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR:
<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>
- [5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. Psychiatry Research, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Asia Oriental 0,51 %, Asia del Sur 0,31 %, Asia Occidental 0,35 %.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>
- [6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. BMC Public Health, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — agrupado 0,14 % (IC 95 % 0,02–0,36 %); rango por país 0,01 % (Omán) a 2,51 % (Arabia Saudí).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>
- [7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. BMC Psychiatry (PMID 38811881) — ~0,7 % desde 2017 (~1 de cada 143). Corroborado por una revisión exploratoria de políticas (SAGE) de 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>
- [8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. General Psychiatry / PMC7916320 — TDAH adulto persistente 2,58 %; sintomático 6,76 %. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>
- [9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — origen de la teoría del monotropismo.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (medida de autoinforme de 47 ítems; preprint de validación). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autistas, 354 no autistas); media autista 4,15 (DE 0,347) vs no autista 3,19 (DE 0,578) en una escala 1–5; el

TDAH predijo independientemente puntuaciones más altas; estructura de 8 factores. Archivo del cuestionario: <https://osf.io/wpx5g> · preprint de validación: <https://osf.io/ft73y> · licencia: CC BY-NC-SA 4.0. Archivo local: `sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf`